

蟹足腫收案平台 - 待確認事項

日期：2026-08-21

以下 5 題，平台目前一律照各題的「目前做法」在跑，您回覆後若不同再調整。

第 1、2 題請優先回覆，因為越晚決定，前面收到的資料越補不回來。

⚠ 1. (優先) 一個病人有好幾顆蟹足腫時，VSS 要每顆各評一次，還是只評主要那一顆？

狀況：VSS 的四個項目（血管分布、色素沉澱、柔軟度、高度厚度）都是在描述「某一顆疤」。目前系統的量表是掛在「病人」身上，不是掛在「病灶」身上，所以一個病人只會留下一份 VSS，事後看不出評的是哪一顆。實際個案中最多的有 5 顆。

JSS 疤痕診斷分類表也有類似情形：12 題裡有 6 題是講單顆疤的（大小、垂直生長、水平生長、形狀、周圍紅斑、主觀症狀），另外 6 題是講病人的（人種、家族傾向、數目、部位、發病年齡、成因）。

請裁決：

- (A) 每顆病灶各評一次 VSS (最完整，但多病灶的病人要重複填多次)
- (B) 只有 VSS 綁病灶，JSS 維持一個病人一份、病灶題以主病灶為準
- (C) 維持現狀，不區分病灶

目前做法：(C)

為什麼急：要改成 (A) 或 (B)，加欄位本身不難；但已經收進來、沒有註明是哪一顆的量表資料，事後沒有人記得起來，補不回去。收到一半才改規則，前後資料會對不起來。

⚠ 2. (優先) 分析會不會用到「病灶尺寸隨時間變小」的變化？

狀況：目前每顆病灶只存一組長寬高。回診重新量的時候，會直接覆蓋掉初診那組數字，舊值不留。也就是說「治療後有沒有變小」這個追蹤研究最核心的結果，目前算不出來。

(8/20 已補上「這組尺寸是哪一天量的」，讓回診時知道有沒有重新量過，但那不是歷史紀錄，舊值一樣會被蓋掉。)

請裁決：

- (A) 每次量測都各存一筆，可以畫出病灶縮小曲線
- (B) 只留最新一次 (現況)
- (C) 只有尺寸有變動時才另存一筆

目前做法：(B)

為什麼急：如果會用到，必須在第一批病人開始回診之前做完。每過一次回診，就永久少掉一個資料點。

3. 術前 vs. 術後一年的 SF-36 / PSQI 比較，是不是主要分析之一？

狀況：同一個病人如果填過好幾次 SF-36，「問卷分數」那張分頁目前只會留下一筆，而且不保證留的是哪一次。PSQI、VSS 也一樣。（JSS 沒有這個問題，它已經會輸出初次 / 最近 / 差值三組。）

請裁決：

- (A) 比照 JSS，SF-36 / PSQI / VSS 也輸出「初次 / 最近 / 差值」
- (B) 改成一列代表一次施測（加上「第幾次填寫」「填寫時間」欄）
- (C) 維持只留一筆，但固定留最新那一次

目前做法：暫時不動，等回覆後再改。

如果術前後比較是主要分析，(A) 或 (B) 必須做。

4. 對照組要放在同一個匯出檔裡嗎？

狀況：對照組是健康受試者，資料獨立存放。但目前的編碼簿只有 4 張主表（Basic Info. / Operation / Year 1 / Year 2），沒有規劃對照組的位置。

請裁決：

- (A) 匯出檔多一張「對照組」分頁（編號、性別、年齡、同意書日期、抽血日期、檢體、Lab 數值）
- (B) 對照組獨立成另一個檔案下載，不混進主檔
- (C) 對照組不匯出，只在系統裡看

目前做法：(A)

問題：跑組間比較時，希望對照組和實驗組在同一個檔案裡，還是分成兩個檔？

5. 回診時要重測哪些量表、多久測一次？

目前規則（已照此實作，請確認）：

量表	頻率	理由
VSS	每次回診	是追蹤治療成效的量表，隔次才測就算不出變化量
SF-36、PSQI	術後 12、24 個月各一次	生活品質一兩個月不會動，每次都問病人會厭煩；正好對上術前 vs. 術後一年的比較
JSS 疤痕診斷分類表	不重測	12 題裡有一半不會變（人種、家族傾向、發病年齡、成因）

請確認：

1. SF-36 / PSQI 除了 12、24 個月，術後 3 個月或 6 個月要不要也測一次？
2. JSS 真的完全不重測嗎？（系統已經有算差值的功能，若要重測就用得上）

改頻率很容易，隨時可調。